

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE
Evaluation du sujet 41 : Les ictères
Résidanat 2025

Pr Ag Elleuch Nour

1. Parmi les propositions suivantes, indiquez-la ou les propositions correctes:

- A. L'ictère est une coloration jaune des téguments liée à une augmentation du taux sérique de la bilirubine conjuguée
- B. L'ictère est visible par l'œil lorsque la bilirubinémie dépasse 17 $\mu\text{mol/L}$
- C. La bilirubine est composée d'une fraction conjuguée (ou directe) et d'une fraction libre (ou indirecte)
- D. Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance conjuguée si la bilirubine conjuguée représente plus que 50%
- E. Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance non conjuguée si la bilirubine directe représente plus que 60 %

Réponse(s) :.....

2. Concernant les voies biliaires extra-hépatiques :

- A. Elles se composent de la voie biliaire principale
- B. Leur fonction principale est le drainage de la bile
- C. La voie biliaire principale se constitue par le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- D. La voie biliaire principale se termine au niveau du premier duodénum
- E. La voie biliaire accessoire comprend la vésicule biliaire et le conduit cystique

Réponse(s) :.....

3. Le confluent biliaire supérieur résulte de l'union :

- A. Du conduit hépatique commun avec le conduit cystique
- B. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique accessoire
- C. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique principal
- D. Du conduit hépatique droit avec conduit hépatique gauche
- E. De l'ampoule hépato-pancréatique avec le duodénum

Réponse(s) :.....

4. Le conduit cholédoque :

- A- Est la portion initiale de la voie biliaire principale
- B- Est situé en amont de l'abouchement du conduit cystique
- C- Se termine dans le deuxième duodénum
- D- Traverse le corps du pancréas
- E- Fusionne avec le conduit pancréatique accessoire pour former l'ampoule hépato-pancréatique

Réponse(s) :.....

5. La vésicule biliaire :

- A- Est située dans la face inférieure du foie
- B- Est formée par un corps et un collet
- C- Le collet est en rapport étroit avec le pédicule du foie droit
- D- S'abouche dans le conduit cystique
- E- Est distendue en cas d'obstacle biliaire intra-hépatique

Réponse(s) :.....

6. La voie biliaire principale est représentée par :

- A- Toutes les voies biliaires extra-hépatiques
- B- Le conduit cystique, le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- C- La vésicule biliaire et le conduit cystique
- D- Le conduit cholédoque
- E- Le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque

Réponse(s) :.....

7. Le conduit cholédoque est en rapport avec:

- A- La queue du pancréas
- B- La face postérieure du premier duodénum
- C- La face médiale (gauche) du deuxième duodénum
- D- La tête du pancréas
- E- Le collet de la vésicule biliaire

Réponse(s) :.....

8. Le carrefour bilio-pancréatique :

- A. Est muni d'un système sphinctérien
- B. Est situé dans le corps du pancréas
- C. Représente un abouchement séparé de la voie biliaire principale et du conduit pancréatique principal puis d'un sphincter commun
- D. Se fait dans le tiers inférieur du deuxième duodénum
- E. N'est exploitable que par la bili-pancréato-IRM

Réponse(s) :.....

9. Concernant la structure de la bilirubine, citer la ou les propositions exactes :

- A. La bilirubine est un dérivé tétrapyrrolique constitué de 4 noyaux pyrroles.
- B. Elle possède une conformation spatiale initiale de type Z/Z.
- C. Dans la conformation Z/Z, les noyaux pyrroles sont disposés sur des plans différents.
- D. La conformation Z/Z confère à la bilirubine un caractère insoluble
- E. Sous l'effet de la lumière, la bilirubine peut adopter des conformations Z/E, E/Z ou E/E.

Réponse(s) :.....

10. Quelles sont les propositions exactes, concernant le transport plasmatique de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée (BNC) libre a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique et les membranes cellulaires
- B. La BNC circule librement dans le plasma
- C. Le transporteur principal est l'Albumine
- D. La BNC peut franchir la barrière glomérulaire
- E. La BNC est retrouvée dans les urines

Réponse(s) :.....

11. Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape hépatocytaire de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée circule librement dans le cytoplasme hépatocytaire
- B. L'étape de la conjugaison de la bilirubine libre se déroule dans le pôle biliaire de l'hépatocyte
- C. L'enzyme bilirubine glucuronyl – transférase assure une simple conjugaison de la bilirubine non conjuguée
- D. La bilirubine conjuguée est parfaitement soluble dans le cytoplasme hépatocytaire

E. La bilirubine conjuguée est transportée vers le pôle biliaire de l'hépatocyte

Réponse(s) :.....

12. La conjugaison de la bilirubine dans l'hépatocyte :

- A. Est réalisée par la UDP-glucuronyl-transférase
- B. A lieu dans le noyau de l'hépatocyte
- C. Rend la bilirubine hydrosoluble
- D. Transforme la BNC en mono- ou di-glucuronide de bilirubine
- E. Se fait grâce à l'albumine intracellulaire

Réponse(s) :.....

13. Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape de sécrétion de la bilirubine ?

- A. La bilirubine forme avec les acides biliaires et le cholestérol la bile
- B. La bilirubine est sécrétée dans la bile grâce à un transport passif
- C. Le flux biliaire (cholérèse) est généré par un transport actif des acides biliaires
- D. Elle suit directement l'étape hépatocytaire de la biliurubine
- E. Elle suit directement l'étape du transport plasmatique de la bilirubine

Réponse(s) :.....

14. Quelles sont les propositions exactes, concernant le devenir de la bilirubine dans l'intestin ?

- A. La bilirubine libre est transformée par les bactéries intestinales en urobilinogène
- B. La bilirubine conjuguée est transformée en stercobiline puis en urobiline
- C. Une petite quantité de l'urobilinogène est réabsorbée par l'intestin
- D. Une fraction de l'urobilinogène regagne le cycle entéro-hépatique.
- E. Une fraction de l'urobilinogène est éliminée dans les urines.

Réponse(s) :.....

15. L'ictère à bilirubine conjuguée peut être secondaire à :

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- C. Un trouble fonctionnel (ictère non cholestatique)
- D. Une destruction excessive de l'hémoglobine
- E. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte

Réponse(s) :.....

16. La cholestase intra-hépatique peut être secondaire à :

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- C. Une obstruction des voies biliaires intra-hépatiques
- D. Une altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte
- E. Une altération des systèmes de transport au niveau des canalicules biliaires.

Réponse(s) :

17. Quelles sont les propositions exactes, concernant la cholestase extra-hépatique ?

- A. Elle est due à une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Elle peut être secondaire à un déficit du transporteur membranaire de la bilirubine conjuguée de l'hépatocyte vers la bile
- C. Elle peut être secondaire à un défaut de stockage hépatique de la bilirubine conjuguée
- D. Elle provoque successivement une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques et des voies biliaires intra-hépatiques
- E. Une inversion de la polarité de l'hépatocyte avec reflux des constituants de la bile dans le sang est observée

Réponse(s) :

18. Parmi les conséquences hépatiques et plasmatiques de la cholestase on note :

- A. Des urines foncées
- B. Un prurit par rétention des sels biliaires
- C. La présence de pigments de bilirubine au sein des hépatocytes et/ou des canalicules biliaires
- D. Une accumulation de cuivre intrahépatocytaire par défaut d'élimination biliaire de ce métal
- E. Une décoloration de selles

Réponse(s) :

19. Parmi les conséquences intestinales de la cholestase on note :

- A. Une décoloration de selles
- B. Une stéatorrhée
- C. Des troubles de la coagulation
- D. Des urines foncées
- E. Une ostéodystrophie

Réponse(s) :.....

20. Un ictère à bilirubine non conjuguée peut être secondaire à

- A. Une destruction excessive de l'hémoglobine (hémolyse)
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- C. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte
- D. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- E. Une conjugaison insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte

Réponse(s) :.....

21. Au cours de l'ictère à bilirubine non conjuguée :

- A. Les selles sont décolorées
- B. Il existe une stéatorrhée
- C. Les urines sont claires
- D. Un prurit est souvent présent
- E. L'ictère est de coloration jaune-orange

Réponse(s) :.....

22. Les signes cliniques en faveur de l'origine cholestatique d'un ictère à bilirubine conjuguée sont :

- A. Des selles plus ou moins décolorées, au maximum mastique
- B. Un prurit
- C. Une hépatomégalie de cholestase
- D. Un ictère de coloration jaune verdâtre
- E. Des urines foncées et mousseuses

Réponse(s) :.....

23. Au cours de l'ictère cholestatique :

- A. Les selles peuvent être normo colorées
- B. Il peut exister une hépatomégalie
- C. Les urines sont claires
- D. Un prurit est souvent présent
- E. La vésicule biliaire peut-être distendue

Réponse(s) :.....

24. Le diagnostic de cholestase biologique peut être porté lorsque :

- A. Un prurit s'associe à une augmentation des phosphatases alcalines (PAL)
- B. Un prurit s'associe à une augmentation de la gamma glutamyl transpeptidases (GGT)
- C. Un ictère à bilirubine conjuguée s'associe à une augmentation des PAL
- D. Une augmentation des PAL s'associe à une cytolyse
- E. Une augmentation des PAL s'associe à une augmentation de la GGT

Réponse(s) :.....

25. Les signes biologiques orientant vers la nature cholestatique de l'ictère sont :

- A. La baisse de l'haptoglobine
- B. L'élévation des transaminases
- C. L'élévation des gamma-glutamyl transpeptidase
- D. L'élévation de la bilirubinémie directe
- E. L'élévation de la cholestérolémie

Réponse(s) :.....

26. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) s'applique(nt) à un ictère à bilirubine libre :

- A. Peut-être dû à une hémolyse
- B. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- C. Est toujours d'origine acquise
- D. Evoque la maladie de Gilbert
- E. S'améliore par l'injection de vitamine K

Réponse(s) :.....

27. L'échographie abdominale :

- A. Représente l'examen morphologique de première intention devant tout ictère cholestatique
- B. Permet de différencier la cholestase extra-hépatique d'une cholestase intra-hépatique
- C. Détermine la nature de l'obstacle dans la majorité des cas
- D. Détermine le siège de l'obstacle dans la majorité des cas
- E. A une meilleure sensibilité et spécificité que la cholangio-IRM pour reconnaître une cholestase extra- hépatique

Réponse(s) :.....

28. Les explorations qui peuvent être à réaliser devant une cholestase extra-hépatique sont:

- A. Les sérologies virales B-C
- B. Le dosage des Ac anticorps anti mitochondries type M 2
- C. L'endoscopie digestive haute
- D. La tomодensitométrie abdominale
- E. La cholangio-IRM

Réponse(s) :.....

29. Dans la maladie de Gilbert, on retrouve :

- A. Une élévation des transaminases
- B. Une hyperbilirubinémie non conjuguée
- C. Une élévation de la GGT
- D. Un ictère aggravé par le jeûne
- E. Une amélioration par le phénobarbital

Réponse(s) :.....

30. Chez un patient ictérique, la palpation d'une grosse vésicule peut évoquer:

- A. Un cancer du hile du foie
- B. Une lithiase du cholédoque
- C. Un kyste hydatique ouvert dans les voies biliaires
- D. Un cancer de la tête du pancréas
- E. Un cholangiocarcinome intra-hépatique

Réponse(s) :.....

31. Devant un ictère cholestatique, avec une dilatation des voies biliaires intra hépatiques à l'échographie, il faut évoquer :

- A- Une hépatite cholestatique
- B- Un cancer du hile du foie
- C- Une cholangite biliaire primitive
- D- Un cancer de la tête du pancréas
- E- Une pancréatite chronique

Réponse(s) :

32. Un ictère nu avec une grosse vésicule biliaire palpable et une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatique peuvent être dû à toutes ces affections, SAUF :

- A- Un calcul enclavé du bas cholédoque
- B- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C- Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D- Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E- Une tumeur de la tête du pancréas

Réponse(s) :

33. Un ictère progressif avec un prurit, sans douleurs ni fièvre, avec une grosse vésicule chez un homme de 58 ans évoque avant tout :

- A - La cirrhose du foie
- B - Le cancer de la vésicule
- C - Le cancer de la tête du pancréas
- D - La lithiase du cholédoque
- E - Une hépatite virale

Réponse(s) :

32. Chez un patient ictérique, une origine hémolytique de l'ictère doit être évoquée devant l'association à :

- A - Une hépatomégalie
- B - Une splénomégalie
- C - Une pâleur cutanéomuqueuse
- D - Des adénopathies périphériques
- E - Une fièvre

Réponse(s) :

33. Devant un patient présentant un ictère cholestatique avec une cytolysé à 15 N, les diagnostics à évoquer sont :

- A - Une cholangite biliaire primitive
- B - Un accident de migration lithiasique
- C - Une hépatite virale
- D - Une tumeur de la tête du pancréas
- E - Une stéatose hépatique

Réponse(s) :

34. Un ictère cholestatique associé à une hépatomégalie siège de multiples nodules à l'échographie fait évoquer :

- A - Des métastases hépatiques
- B - Des abcès du foie
- C - Un foie cardiaque
- D - Une stéatose hépatique
- E - Une hépatite virale

Réponse(s) :

35. Un ictère cholestatique associé à un épisode de méléna évoque en premier lieu :

- A- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- B- Un ampulome Vaterien
- C- Une lithiasse de la voie biliaire principale
- D- Un kyste hydatique du foie compliqué
- E- Un cancer du corps du pancréas

Réponse(s) :

36. L'association d'une fièvre et d'un ictère à une douleur de l'hypochondre droit chez un patient connu porteur d'un kyste hydatique du foie évoque en premier lieu :

- A- Une suppuration de la cavité kystique
- B- Une rupture du kyste en péritoine libre
- C- Une ouverture du kyste dans le thorax
- D- Une ouverture du kyste dans les voies biliaires
- E- Une compression extrinsèque du pédicule hépatique

Réponse(s) :

37. Un ictère cholestatique qui survient chez un patient cirrhotique fait évoquer en premier lieu le diagnostic suivant :

- A- Un abcès du foie
- B- Un angiome volumineux du foie
- C- Un Kyste hydatique du foie
- D- Un carcinome hépato-cellulaire
- E- Des métastases hépatiques

Réponse(s) :

Cas clinique N°1

Un homme de 74 ans est hospitalisé pour un ictère cutanéomuqueux ayant débuté il y a deux semaines. A l'interrogatoire on retrouve un prurit ayant débuté 20 jours auparavant conjointement à des douleurs de l'hypochondre droit à irradiation postérieure en hémi ceinture.

L'examen clinique trouve une hépatomégalie régulière à bord mousse et un ictère intense avec une grosse vésicule.

Au toucher rectal le doigtier revient souillé de matières fécales blanches mastic.

Biologie : bilirubinémie totale : $130\mu\text{mol/L}$; phosphatases alcalines 6N ; ASAT à 2N; Le TP est à 40% ; l'Hb est à 10 mg/100ml

1. Quels sont les éléments cliniques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Les urines foncées
- B. Les selles décolorées
- C. Les douleurs de l'hypochondre droit
- D. Le prurit
- E. La présence d'une hépatomégalie à bord inférieur mousse

Réponse(s) :

2. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée
- B. Une cytolyse
- C. Des phosphatases alcalines élevées
- D. Une anémie à 10 g/dl
- E. Une baisse du TP

Réponse(s) :

3. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique

Réponse(s) :

4. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque
- B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C. Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D. Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E. Une tumeur de la tête du pancréas

Réponse(s) :.....

5. Quel est l'examen complémentaire à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM
- C. Un scanner abdominal
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique
- E. Une duodénoscopie

Réponse(s) :.....

Cas clinique N°2

Un jeune de 16 ans consulte pour un ictère cutanéomuqueux constaté il y a 2 jours. Il rapporte une gastro-entérite survenue il y a 5 jours avec une bonne évolution sous traitement symptomatique.

L'examen physique objective un ictère cutanéomuqueux franc.

Les explorations biologiques ont révélé :

Une bilirubinémie totale : 89 μ mol/L (BC : 49 μ mol/L) ; des phosphatases alcalines 5N ; GGT : Normales , ASAT : 15N , ALAT : 20N , TP : 75% ; Hb : 12g/100ml

Le diagnostic d'une hépatite aigue a été retenu.

1- Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent de retenir le diagnostic d'une hépatite aigue ?

- A. L'âge jeune du patient

- B. Un tableau de gastro-entérite suivi par l'apparition de l'ictère
- C. Une hyperbilirubinémie
- D. Une cytolysé importante
- E. Une cholestase importante

Réponse(s) :.....

2- Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent d'évaluer la gravité d'une hépatite aigüe ?

- A. L'intensité de l'ictère
- B. Une asthénie manifeste
- C. La présence d'un flapping trémor
- D. Une baisse du taux de prothrombine (TP)
- E. Une cytolysé >100 Normale

Réponse(s) :.....

3- Quelles sont les explorations à demander en première intention dans le cadre du bilan étiologique devant une hépatite aigüe ?

- A. Une échodoppler abdominale
- B. Une sérologie virale à CMV et VZV
- C. Une sérologie virale A : anticorps anti VHA type Ig M
- D. Une sérologie virale B : anticorps anti VHB type Ig M, Ag Hbs
- E. Un bilan immunologique

Réponse(s) :.....

Cas clinique N°3 :

Un patient âgé de 21 ans vous consulte pour une coloration jaunâtre des yeux qui évolue depuis quelques années de façon intermittente. Ses urines étaient claires. Ses selles étaient normo colorées. Il ne rapportait ni prurit ni altération de l'état général. L'examen physique est sans particularités.

Le bilan biologique a montré: Bilirubine totale=50 µmol/l, Bilirubine directe=10 µmol/l, GGT=16 UI/l, PAL=86 UI/l, ASAT=22 UI/l, ALAT=21 UI/l

NFS : GB=8600, Hb=13g/dl, plaquettes=180000éléments/m³, TP=85%

Haptoglobine et LDH normaux.

1-Les signes cliniques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée présents chez ce patient sont:

- A. Des urines claires
- B. Des selles normocolorées
- C. L'absence de prurit
- D. L'évolution intermittente
- E. L'état général conservé

Réponse(s) :

2-Le diagnostic le plus probable chez ce patient est :

- A. Une hémolyse
- B. Une maladie de Rotor
- C. Une maladie de Dubin-Jhonson
- D. Une maladie de Gilbert
- E. Une hépatite virale

Réponse(s) :

3-Quelle prise en charge préconisez-vous chez ce patient ?

- A. Exploration morphologique par une échographie abdominale
- B. Exploration morphologique par une endoscopie digestive haute
- C. Exploration morphologique par une cholango-IRM
- D. Transfusion par des culots globulaires
- E. Aucun traitement

Réponse(s) :

Cas clinique 4 :

Une femme de 43 ans consulte les urgences devant la survenue d'une douleur de l'hypochondre droit suivie d'une fièvre et d'un ictère évoluant depuis 24 h. Les examens biologiques ont montré : bilirubinémie totale : 120 μ mol/L ; bilirubinémie conjuguée: 100 μ mol/L ; phosphatases alcalines 6N ; GGT à 3N ; ALAT à 5 N ; ASAT à 7N; CRP à 100 mg/L, Hb à 12g/dl, GB : 18000, Plq à 220000.

1. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée
- B. Une cytolyse
- C. Une CRP élevée
- D. Une hyperleucocytose
- E. Une anémie

Réponse(s) :

2. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique

Réponse(s) :

3. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, avec une vésicule biliaire lithiasique, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque
- B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C. Un ampullome vatérien
- D. Un kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires
- E. Une tumeur de la tête du pancréas

Réponse(s) :

4. Quels sont les examens complémentaires à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM
- C. Un scanner abdominal
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique
- E. Une duodénoscopie

Réponse(s) :